



Εξειδικευμένη Υποστήριξη Ζωής

Αλγόριθμος βραδυκαρδίας

A
B
C
D
E

- Εκτίμησε με βάση την προσέγγιση ABCDE
- Βεβαιωθείτε για τη χορήγηση οξυγόνου και εξασφαλίστε ενδοφλέβια πρόσβαση
- Παρακολουθήστε το ΗΚΓ, Α/Π, SpO₂, κατάγραψε ΗΚΓ 12 απογώνων
- Προσδιόρισε και θεράπευσε τις αναστρέψιμες αιτίες (π.χ. ηλεκτρολυτικές διαταραχές)

Αξιολόγησε για την ύπαρξη
δυσμενών σημείων
1 Καταπληξία
2 Συγκοπή
3 Μυοκαρδιακή ισχαιμία
4 Καρδιακή ανεπάρκεια

Ναι

Όχι

Ατροπίνη
500mcg ΕΦ

Ικανοποιητική
Ανταπόκριση;

Ναι

Όχι

Ναι

Προσωρινά μέτρα:

- Ατροπίνη 500mcg ΕΦ
Επανάλαβε μέχρι το μέγιστο των 3mg
- Ισοπρεναλίνη 5mcg min⁻¹
- Αδρεναλίνη 2-10mcg⁻¹
- Εναλλακτικά φάρμακα*
- ή
- Διαδερμική βηματοδότηση



Αναζήτηση εξειδικευμένης
βοήθειας
Διευθετήστε διαφλέβια
βηματοδότηση

* Εναλλακτικές επιλογές φαρμάκων:

- Αμινοφυλλίνη
- Ντοπαμίνη
- Γλουκαγόνο (εάν υπερδοσολογία β αποκλειστών ή αποκλειστών διαύλων ασβεστίου)
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί γλυκοπυρολάτη αντί ατροπίνης

Κίνδυνος ασυστολίας;
• Πρόσφατη ασυστολία
• Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 2ου βαθμού Mobitz II
• Πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός με ευρέα συμπλέγματα QRS
• Κοιλιακή παύση >3 δ

Όχι

Συνεχίστε παρακολούθηση

